

Les Schémas Précoces Inadaptés

Les schémas

La **définition** de Young, des Schémas Précoces Inadaptés (SPI), est la suivante :

- . un modèle ou un **thème important et envahissant**,
- . constitué de souvenirs, d'émotions, de cognitions et de sensations corporelles,
- . **concernant soi-même et ses relations avec les autres**,
- . constitué au cours de l'enfance ou de l'adolescence,
- . enrichi tout au long de la vie de l'individu, et dysfonctionnel de façon significative. (2005, p.34).

Les Schémas Précoces Inadaptés (SPI), qui s'élaborent au cours de l'enfance et/ou de l'adolescence, continuent à s'enrichir tout au long des expériences de la vie, même s'ils sont inappropriés, s'ils ne servent plus à rien ou sont même nuisibles. En fait, la personne adulte qui fait l'expérience de l'activation d'un de ses schémas, vit cette expérience émotionnelle d'une façon semblable à ce qu'elle a vécu lors de l'élaboration de son schéma. Il est question ici de **continuité cognitive, de vision stable de soi-même et du monde, même si celle-ci est en fait imprécise ou erronée**.

Notons que les schémas peuvent être positifs ou négatifs, adaptés ou inadaptés. La **psychothérapie centrée sur les schémas s'intéresse aux schémas qui sont inadaptés. Ces schémas constituent le noyau des troubles de la personnalité, des problèmes caractérogiques et de nombreux troubles majeurs comme les troubles thymiques (dépression, bipolarité, etc.), l'anxiété**, des troubles du comportement alimentaire etc. (2005, p.34).

Il est donc question **d'interprétation distordionnée, de la réalité**, qu'a la personne.

Caractéristiques des schémas

Les schémas sont élaborés pour se nourrir et perdurer tout au long de la vie de l'individu. On dit que les schémas se "battent" pour survivre.

Les schémas apparaissent au cours de l'enfance ou de l'adolescence en tant que représentations de l'environnement de l'enfant et sont basés sur la réalité.

La nature **dysfonctionnelle des schémas se manifeste plus tard au cours de la vie, au moment où les personnes commencent à perpétuer leurs schémas dans leurs interactions avec les autres, avec des perceptions qui ne sont plus exactes, ni adaptées**.

Les schémas sont dimensionnels, ce qui signifie qu'ils peuvent avoir différents niveaux d'envahissement et de gravité (2005, p. 35), etc.

Young a observé quatre types d'expériences de vie précoces qui concourent à la constitution des schémas inadaptés :

1. La frustration de besoins

Par exemple, la frustration des besoins de stabilité, de compréhension ou d'amour contribue à la formation des schémas tels que le manque affectif ou l'abandon-instabilité.

2. La traumatisation ou la victimisation

L'enfant victimisé ou maltraité pourra développer des schémas de méfiance/abus,

d'imperfection/honte ou de peur du danger ou de la maladie.

3. L'excès de satisfaction des besoins

La formation d'un schéma inadapté ne provient pas nécessairement d'un traumatisme ou de frustration de besoins. Elle peut provenir d'un excès de bonnes choses qu'il serait sain de recevoir de façon plus modérée. Par exemple, l'enfant gâté, choyé, pour qui les parents font tout ne verra pas ses besoins d'autonomie et de limites comblés et pourra développer un SPI de dépendance /incompétence ou de droits personnels exagérés/grandeur.

4. L'internalisation ou l'identification sélective à des personnes importantes

Par exemple l'enfant violenté par le parent, s'identifie à ce parent, internalise ses pensées, ses émotions et ses comportements et sera lui-même un adulte violent.

Les besoins affectifs fondamentaux

Les schémas sont la conséquence de besoins affectifs fondamentaux qui n'ont pas été comblés au cours de l'enfance et/ou de l'adolescence. Voici les **cinq besoins affectifs fondamentaux** de l'humain qui sont proposés :

1. La sécurité liée à l'attachement aux autres (comprend la stabilité, la sécurité, l'éducation attentive et l'acceptation).
2. L'autonomie, la compétence et le sens de l'identité.
3. La liberté d'exprimer ses besoins et ses émotions.
4. La spontanéité et le jeu.
5. Les limites et l'autocontrôle.

Ces besoins sont universels et un individu sain, sur le plan psychologique, est une personne qui parvient à combler de façon adaptée ses besoins affectifs fondamentaux. **Le but de la Thérapie des Schémas est d'aider les personnes à trouver des moyens adaptés pour satisfaire leurs besoins affectifs fondamentaux. C'est la finalité de toutes nos interventions.**

Table 40.1. Eighteen Early Maladaptive Schemas/Developmental Domains and Unmet Needs

Schema Domain	Frustrated Basic Need	Schemas
I: Disconnection and Rejection	Secure attachment (stability, empathy, nurturance, guidance, acceptance)	1. Abandonment 2. Mistrust/Abuse 3. Emotional Deprivation 4. Defectiveness/Shame 5. Social Isolation
II: Impairment of Competence and Autonomy	Autonomy, competence, and sense of identity	6. Dependence/Incompetence 7. Vulnerability to Harm 8. Enmeshment/Undeveloped Self 9. Failure
III: No Limits	Realistic limits and self-control	10. Entitlement/Grandiosity 11. Insufficient Self-Control/ Self-Discipline
IV: Other Directedness	Freedom to express valid needs and emotions	12. Subjugation 13. Self-Sacrifice 14. Approval Seeking
V: Overvigilance and Inhibition	Spontaneity and play	15. Negativity/Pessimism 16. Emotional Inhibition 17. Unrelenting Standards 18. Punitiveness

Les domaines de schémas et les schémas précoces inadaptés

Dans ce modèle, 18 schémas sont regroupés en 5 grandes catégories de besoins affectifs non comblés, les cinq « domaines de schémas ».

A- Domaine de la séparation et du rejet

Le patient est convaincu que ses attentes concernant les besoins de sécurité, de stabilité, d'empathie, d'expression des émotions, d'acceptation et de respect ne seront pas comblés. La famille d'origine typique de ce genre de schéma est caractérisée par le détachement, la froideur, le rejet, la solitude, les refus, l'explosion des émotions ainsi que par son caractère imprévisible et abusif.

1) Schéma de l'abandon/instabilité

La personne perçoit une instabilité dans la relation aux personnes significatives. De plus, elle a l'impression que les gens importants de sa vie ne continueront pas à être là, car ils sont non prévisibles émotionnellement, ils ne sont présents que sporadiquement, ils vont mourir ou ils quitteront la personne pour une autre personne meilleure. Tels sont les a priori qu'a la personne ayant un tel SPI.

2) Schéma de la méfiance et de l'abus

La personne ayant ce schéma a la conviction, que lorsqu'ils en auront l'occasion, les autres vont les utiliser à leurs fins égoïstes. Par exemple, ils vont abuser, heurter, humilier, tromper ou manipuler le patient.

3) Schéma de la carence affective

La personne anticipe que ses propres désirs, dans une relation affective, ne seront jamais adéquatement comblés.

Il y a trois types de carences :

- A) Manque de soin (absence d'affection)
- B) Manque d'empathie (absence d'écoute et de compréhension)
- C) Manque de protection (absence de guidance et de soutien par les autres).

La personne peut avoir souffert d'un, de deux ou de trois types de carences à la fois.

4) Schéma de l'imperfection et de la honte

Le patient a le sentiment qu'il est mauvais, inférieur, sans valeur, imparfait et non aimable. Le schéma augmente habituellement le sentiment de la honte en regard de ses perceptions auto-dépréciatrices. L'imperfection peut être privée (égoïsme, pulsions agressives, désirs sexuels inacceptables, manque de talent, d'intelligence, de créativité etc.), ou publique (non attirant physiquement, maladroit socialement).

5) Schéma d'exclusion (sociale) / isolement social / alienation

La personne a l'impression d'être différente des autres, ou de ne pas faire partie de la société ou du groupe. Typiquement, le patient ayant ce schéma ne sent pas qu'il peut appartenir à aucun groupe dans la communauté.

B- Domaine de l'autonomie et des performances altérées

L'autonomie est l'habileté à se séparer de sa famille et de fonctionner indépendamment d'une façon comparable aux gens de son groupe d'âge. Quand ces personnes étaient des enfants, leurs parents faisaient tout pour eux et les surprotégeaient, ou à l'opposé (mais c'est plus rare) s'occupaient à peine d'eux. Les deux extrêmes peuvent mener à des problèmes d'autonomie. Ces personnes n'arrivent pas à devenir des adultes dans la vie.

6) Schéma de dépendance/incompétence

Les patients au prise avec ce schéma se sentent incapables d'assumer leurs responsabilités quotidiennes sans une aide substantielle des autres. Par exemple, ils n'arrivent pas à gérer leur argent, à résoudre des problèmes concrets, à user de bon jugement, à entreprendre de nouvelles tâches ou à prendre des décisions adéquates. Il n'est pas ici question de dépendance affective émanant de schémas d'abandon et/ou de carence affective mais plutôt de dépendance fonctionnelle.

7) Schéma de vulnérabilité (peur du danger ou de la maladie)

Ce schéma est caractérisé par une crainte excessive qu'une catastrophe ne survienne à n'importe quel moment et avec laquelle il ne pourrait pas « survivre ».

Il y a trois types de peurs :

1. Reliée à la santé : crise cardiaque, sida, etc.
2. Reliée aux émotions : perdre la raison, perdre le contrôle, etc.
3. Reliée aux catastrophes naturelles ou à des phobies (ascenseurs, crimes, avions, tremblements de terre, etc.)

8) Schéma de fusion/ soi peu développé

Ces patients étaient souvent surinvestis par leurs parents au détriment de leur individualisation et de leur développement social. Ces patients croient fréquemment que l'une des personnes de la relation fusionnelle ne peut vivre sans l'autre.

9) Schéma d'échec

Ce schéma est caractérisé par la croyance que le patient échouera inévitablement dans des secteurs où il doit performer (études, profession, sport) et qu'il sera fondamentalement inadéquat comparativement à ses pairs.

Nous pouvons faire ici un parallèle entre le schéma d'imperfection et le schéma d'échec : avec le schéma d'imperfection, il est question d'une imperfection de l'être (mauvais, inférieur, sans valeur, imparfait et non aimable), alors qu'avec le schéma d'échec, il est question d'une incompétence du faire (performance : études, travail, sport, etc.).

C- Le domaine des limites déficientes

Les patients avec ces schémas n'ont pas développé des limites internes adéquates au sujet de la réciprocité et de l'autodiscipline. Ils ont de la difficulté à respecter les droits des autres, à coopérer, à remplir leurs engagements ou à rencontrer leurs buts à long terme. Ces patients se présentent souvent comme égoïstes, gâtés, irresponsables ou narcissiques. Ils ont grandi typiquement dans des familles qui étaient très permissives et indulgentes. Comme adulte, ils manquent de capacité à restreindre leurs impulsions et à retarder les gratifications immédiates au nom de bénéfices futures.

10) Schémas des droits personnels exagérés / de grandeur (Tout m'est dû)

Schéma caractérisé par la croyance que le patient est supérieur aux autres et qu'il peut avoir des droits ou des privilèges particuliers. Ces patients ne se sentent pas liés par les règles de réciprocité qui guident les interactions sociales normales. Ils insistent souvent sur le fait qu'ils devraient pouvoir faire ce qu'ils veulent, sans égard au prix que les autres auraient à payer pour leurs privilèges. Ces patients sont souvent exigeants envers les autres, dominants et manquant d'empathie.

Ce schéma pourrait aussi être une forme de surcompensation à un autre schéma, tel carence affective.

11) Schéma de discipline personnelle et maîtrise de soi insuffisantes

Ces patients n'arrivent pas à exercer un auto-contrôle suffisant et une tolérance à la frustration qui leur permettraient d'atteindre leurs buts. Ils n'arrivent pas à réguler l'expression de leurs émotions et de leurs impulsions.

D- Domaine de la centration sur autrui

Dans les schémas de ce domaine, les patients mettent une emphase excessive vers la satisfaction des besoins des autres, plutôt que vers leurs propres besoins et préférences. Ils font ça dans le but d'avoir l'approbation, de maintenir une relation ou pour éviter les représailles. Comme enfants, ils n'étaient pas libres de suivre leurs désirs naturels. Comme adultes, plutôt que d'être guidés par eux-mêmes, ils se laissent guider par les désirs des autres. La famille d'origine typique de ces patients est caractérisée par l'acceptation conditionnelle, c'est-à-dire que l'enfant doit restreindre d'importants aspects de lui-même pour obtenir de l'amour et de l'approbation.

12) Schéma d'assujettissement

Les patients victimes de ce schéma démontrent une excessive capitulation au contrôle des autres, car ils s'y sentent contraints. La fonction de l'assujettissement est habituellement d'éviter la rage, les représailles ou l'abandon. Les deux formes majeures sont l'assujettissement des besoins (suppression des préférences et des désirs personnels) et l'assujettissement des émotions (suppression de ses propres réponses émotionnelles, principalement de la rage). L'assujettissement mène souvent à une accumulation de la rage qui se manifeste par différents symptômes tels que les comportements passifs-agressifs, les crises incontrôlables, les symptômes psychosomatiques et l'évitement de l'affection.

13) Schéma de sacrifice de soi / abnégation

Les patients ayant ce schéma, tentent volontairement de satisfaire les besoins des autres au détriment de leurs propres besoins. Ils agissent ainsi dans le but d'épargner de la douleur aux autres, éviter la culpabilité, gagner de l'estime personnelle ou maintenir une relation émotionnelle avec une personne qu'ils perçoivent significative. Ces patients expriment une sensibilité aiguë aux souffrances de l'autre. Ce schéma augmente la sensation que les besoins personnels ne sont pas rencontrés adéquatement, ce qui mène à l'amertume.

14) Schéma de recherche d'approbation

Ce schéma est caractérisé par une valorisation dans l'obtention de l'approbation et de la reconnaissance des autres, au détriment du développement d'une identité sécurisée et authentique. L'estime personnelle dépend ici des autres plutôt que de sa propre évaluation. Ce schéma inclut souvent une préoccupation excessive du statut social, de l'apparence, de la richesse, et du succès dans l'optique d'obtenir l'approbation et la reconnaissance.

E- Domaine de la vigilance à outrance et de l'inhibition

Les patients ayant des schémas dans ce domaine suppriment leurs sentiments spontanés et leurs impulsions. Ils s'efforcent souvent d'instaurer des règles rigides et internes au sujet de l'expression de leur joie, de l'expression de soi, de la relaxation, de leurs relations et de leur bonne santé. L'origine de ces schémas vient d'une enfance sévère, réprimée, stricte où l'auto-contrôle et l'abnégation prédominaient sur la spontanéité et le plaisir. Dans l'enfance, les parents n'encourageaient pas les jeux et le plaisir.

15) Schéma négativisme / pessimisme

Ce schéma est caractérisé par une vision envahissante et constante des aspects négatifs de la vie (douleur, mort, pertes, désappointements, conflits, trahisons, catastrophes) tout en minimisant les aspects positifs. Dû au fait que le patient exagère le potentiel négatif des événements, ce dernier est souvent caractérisé comme étant soucieux, inquiet, hypervigilant, plaignard et indécis.

16) Schéma d'inhibition émotionnelle

Le patient exerce ici un contrôle excessif sur ses actions, sentiments et affirmations. Il se restreint dans le but de prévenir la critique ou la perte de contrôle de ses impulsions.

Les quatre secteurs les plus concernés sont :

- . l'inhibition de la colère et de l'agressivité,
- . le contrôle des impulsions positives (sentiments affectifs, sexualité, amusement, etc.),
- . la difficulté à reconnaître ses faiblesses et sa vulnérabilité, la difficulté à exprimer ses sentiments ou besoins.
- . l'importance excessive accordée à la raison par rapport aux émotions.

17) Schéma d'exigences élevées

Ce schéma est caractérisé par une préoccupation à correspondre à de hauts standards, habituellement dans le but d'éviter la désapprobation ou la honte. Ce schéma résulte en une pression constante et une critique continue envers soi-même et les autres. Pour être considérées comme un schéma, ces caractéristiques doivent créer une détérioration importante au sujet de la santé du patient, de son estime personnelle, de ses relations ou de ses expériences plaisantes.

Ce schéma se manifeste typiquement par,

- 1) du perfectionnisme (besoin de bien faire les choses, porter une attention excessive aux détails, sous-estimer son niveau de performance),
- 2) des règles rigides (les « il faut » dans plusieurs secteurs de la vie, incluant des standards non réalistes de morale, de culture ou de religion)
- 3) une préoccupation au sujet du temps et de l'efficacité (il faut toujours faire vite et mieux).

Ce schéma peut aussi être, une stratégie de contre-attaque du schéma d'échec, d'imperfection ou d'exclusion, ou une réponse aux introjections parentales (mode du parent exigeant).

18) Schéma de punition

Ce schéma est caractérisé par une conviction que les gens peuvent être punis s'ils font des erreurs. Ce schéma augmente la tendance à être exigeant et intolérant avec les gens (ainsi qu'avec soi-même), si les standards ne sont pas rencontrés. Il inclut habituellement une difficulté à pardonner les erreurs, car le patient est peu enthousiaste à considérer les circonstances atténuantes à tolérer les imperfections humaines ou à considérer les intentions de l'autre.

source <http://www.jobinseigny.ca> (adapté)